

15/08
15:30

INDICADO POR: Dr. Cavalcanti / Dr. Beldrin

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

ANTONIO RICARDO SILVEIRA FERREIRA

IDADE: 38	PESO: 106	ALTURA: 1,89	PROFISSÃO: ADM
SINTOMAS: cansaço e sonolência diurna			
QUEIXAS: sono intermitente			
MEDICAMENTOS: não - Magnésio (Bisglicinato)			
MÉDICO: Dra. Camila Toledo / Dr. Beldrin (Pneumo) / Dr. Abelardo			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 19-19:30			
HORA QUE DORME: 23h - 0:30h HORA QUE ACORDA: 6 - 7h			
COCHILO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE			
TEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N			
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N			
FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO/NOITE: 1-2x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI:	IAH: 60cm	SPO2: 64% / spo2 86%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Distrofia neuro muscular / Fadiga estomacal			
CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA		(N) NEUROLÓGICA () OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N		SPO2 C/ CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:
15/05/25 Análise de titulação		{ P = 10cmH ₂ O	
11/06/25 / 2º início da adaptação de		{ IAH = 15,2 e fcv	
Bipap (modo auto)		{ SpO ₂ min = 71%	
IPAP = 13,0		{ SpO ₂ med. = 90%	
EPAP = 9,0			
13/06		máx. Duam Pillow	
IPAP = 12 / EPAP = 8		4cmH ₂ O PS	
IAH = 12,2 e fcv			
fupv = 15,0 e pue			
m. de uso: 7hr			
25			
IPAP = 10 EPAP = 6		PS 40 cmH ₂ O.	

04/07
25

(P) IPAP = 10 cmH₂O

EPAP = 6 cmH₂O

IAH = 12.9

AC = 8.6 elev

IH = 1.9 elev

fuga = 17.1 med

Dias
23/23

18 4 (4 h)

5 4 hr.

lua.

Biologia 2d

IPAP = 10

EPAP = 6

fuga = 14.9

M. de uso: 7h

IAH = 15.1 (AC = 8.6 / AO = 35)

lua

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: ANTONIO RICARDO SILVEIRA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 04-04-2025

Idade: 38 anos

Peso: 110 kg

Altura: 1,89 m

Médico Solicitante: DRA. CAMILA TOLEDO TURANO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 04/04/2025 21:35 e finalizado às 05/04/2025 05:43.

A latência para início do sono foi de 13,0 min e a latência para o sono REM de 120,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 428,0 min, com eficiência do sono de 88,2 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 6,2 % de estágio N1, 47,4 % de estágio N2, 27,6 % de estágio N3 e 18,8 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 44,4 min. Ocorreram 142 despertares, sendo o índice de 17,4 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 431, sendo 100 apneias obstrutivas, 1 apneias centrais, 0 apneias mistas, 330 hipopneias e 0 "RERAS". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 60,4 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 64,1 e o IDR durante o sono NREM foi de 59,6. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 60,4 (nº/h), sendo 14,2 apneia/h e 46,3 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 91%, a média de 86% e a mínima de 64%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 59,7 (nº/h), sendo que em REM foi de 105,8 (nº/h) e em NREM foi de 59,4 (nº/h). Permaneceu 66,8 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Nome: ANTONIO RICARDO SILVEIRA

Data do Exame: 04-04-2025

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (60,4 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (64%);
3. Latência para o início do sono (13,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (120,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (88,2 %) (VN= $\geq$ 85%);
6. Índice de despertares 17,4 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (6,2 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (47,4 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (27,6 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (18,8 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

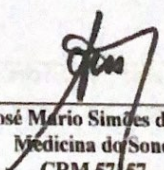
Exame evidenciando Índice de distúrbio respiratório e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57